

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN SALUD (eHEALS)

The eHealth Literacy Scale (Norman & Skinner, 2006) · Adaptación Española (Paramio Pérez et al., 2015)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Alfabetización Digital en Salud (eHealth Literacy Scale, eHEALS)
Sigla / Acrónimo	eHEALS
Autoría original	Cameron D. Norman & Harvey A. Skinner (Dalla Lana School of Public Health, Univ. of Toronto, 2006)
Adaptación en español	Paramio Pérez, Almagro, Hernando Gómez & Aguaded (2015, Rev Esp Salud Publica)
Constructo evaluado	Habilidades y confianza autopercebidas para buscar, encontrar, evaluar y aplicar información de salud obtenida en internet
Población diana	Adolescentes, jóvenes y adultos en programas de telemedicina, eSalud y educación para la salud digital
Tiempo de aplicación	2 a 4 minutos (autoadministrado vía telemática o presencial)
Estructura y formato	8 ítems puntuados en escala tipo Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo)
Condiciones de uso	Acceso abierto bajo licencia Creative Commons Attribution (CC-BY 2.0) citando a Norman & Skinner (2006)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La proliferación de internet y las tecnologías móviles ha transformado la manera en que los ciudadanos gestionan su salud. Sin embargo, la abundancia de datos electrónicos coexiste con una saturación masiva de información errónea o engañosa (**infodemia**), pseudociencia y algoritmos comerciales. En este entorno, la alfabetización digital en salud (**eHealth literacy**) se define como la capacidad integral para buscar, seleccionar, comprender y juzgar críticamente el conocimiento sobre salud procedente de fuentes electrónicas, así como para aplicar dicho conocimiento a la resolución de problemas de salud individuales.

El modelo del “lirio” de Norman y Skinner (**Lily Model**) concibe la alfabetización digital en salud como la convergencia de seis alfabetizaciones fundacionales interconectadas: alfabetización tradicional (lectoescritura), alfabetización en salud, alfabetización informacional, alfabetización científica, alfabetización en medios de comunicación y alfabetización informática/digital. El eHEALS fue diseñado para proporcionar una métrica estandarizada y operativa de este constructo polifacético.

3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS 8 ÍTEMS DEL eHEALS

Ítem	Habilidad Específica Evaluada	Escala	Proceso de Alfabetización
1	Sé qué recursos de salud útiles están disponibles en internet	1 a 5	Conocimiento de recursos electrónicos
2	Sé dónde encontrar recursos de salud útiles en internet	1 a 5	Navegación y localización web
3	Sé cómo encontrar recursos de salud útiles en internet	1 a 5	Estrategia de búsqueda de información
4	Sé cómo usar internet para responder mis preguntas de salud	1 a 5	Aplicación práctica operativa
5	Sé cómo usar la información sobre salud para ayudarme	1 a 5	Toma de decisiones de autocuidado
6	Tengo las habilidades necesarias para evaluar recursos de salud	1 a 5	Juicio crítico sobre la evidencia web
7	Sé distinguir entre recursos de salud de alta y baja calidad	1 a 5	Discriminación de fuentes e infodemia
8	Me siento seguro/a usando información de internet para mi salud	1 a 5	Autoeficacia digital en salud global

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente consistencia global; alfa de Cronbach $\alpha = 0.87 - 0.89$ en la validación española de Paramio Pérez et al. (2015) y $\alpha = 0.88$ en el estudio original canadiense.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 3 semanas con coeficiente de correlación de Pearson $r = 0.78$ ($p < 0.001$), evidenciando una notable estabilidad temporal.
Estructura factorial	Estructura unidimensional comprobada mediante análisis factorial confirmatorio (RMSEA = 0.054, CFI = 0.98), con todas las cargas factoriales superiores a 0.65.
Validez convergente	Correlación positiva significativa con la frecuencia de búsqueda de información médica online ($r = 0.45$), autoeficacia general ($r = 0.42$) y conductas promotoras de salud.
Sensibilidad al cambio	Muestra incrementos significativos tras la realización de módulos formativos en telemedicina y pensamiento crítico ante bulos de salud en internet.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Opciones de graduación	Cada ítem se puntúa de 1 a 5: 1 = Totalmente en desacuerdo ; 2 = En desacuerdo ; 3 = Indeciso / Neutro ; 4 = De acuerdo ; 5 = Totalmente de acuerdo .
Puntuación directa total	Suma aritmética simple de los 8 ítems. Rango teórico posible: 8 a 40 puntos . No existen ítems invertidos.
Puntuación media opcional	En algunos estudios comparativos se utiliza la media por ítem: " Media eHEALS " = (Total) / 8 . Rango: 1.0 a 5.0 puntos .
Preguntas suplementarias	Los dos ítems preliminares originales ("¿Qué tan útil es internet para su salud?" e "Importancia de acceder a recursos") son cualitativos y no computan al total.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Percentil	Nivel de Competencia	Significación y Comportamiento en Salud Digital
8 - 20 puntos	< Pc 25	Baja Alfabetización Digital	Desconocimiento de fuentes fiables; alta vulnerabilidad a bulos y fraude.
21 - 29 puntos	Pc 25 - Pc 65	Competencia Moderada	Navegación básica habitual pero con dudas al contrastar la calidad médica.
30 - 40 puntos	> Pc 65	Alta Alfabetización Digital	Excelente criterio crítico; uso activo y provechoso de la telemedicina.

PUNTOS DE CORTE Y RECOMENDACIÓN PRÁCTICA:

- **eHEALS < 26 puntos (o Media < 3.25):** Define baja competencia digital en salud. Pacientes en este estrato que buscan información sobre síntomas en redes sociales o foros no verificados tienen un riesgo elevado de angustia innecesaria (cibercondría) o abandono de fármacos por pseudociencia.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE PRESCRIPCIÓN DE RECURSOS DIGITALES EN SALUD

Paso 1: Aplicación del eHEALS: Obtener puntuación total (8 a 40) en pacientes usuarios de aplicaciones móviles o portales de salud.

Paso 2: Si eHEALS 8 — 20 (Baja Alfabetización Digital):

- Evitar la derivación exclusiva a telemedicina sin soporte presencial complementario.
- Desaconsejar formalmente la búsqueda de diagnósticos en buscadores genéricos o redes sociales sin supervisión.

Paso 3: Si eHEALS 21 — 29 (Moderada): Realizar "prescripción de enlaces web fiables" (entregar por escrito o código QR webs institucionales acreditadas: MedlinePlus, sociedades científicas oficiales, portales de salud autonómicos).

Paso 4: Si eHEALS 30 — 40 (Alta): Integrar plenamente al paciente en plataformas de telemonitorización, portales de resultados analíticos y herramientas de autogestión telemática.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO DE CIBERCONDRIA EN SALUD DIGITAL

Identificación: Mujer de 34 años, diseñadora gráfica, que acude angustiada a consulta de Medicina de Familia convencida de padecer un linfoma tras notar una adenopatía retroauricular de 5 mm posterior a un cuadro catarral, tras consultar foros de internet durante 3 días seguidos.

Evaluación eHEALS Inicial: Puntuación Total = **18 / 40** (Baja Alfabetización Digital en Salud).

- Ítem 6 (Habilidades para evaluar recursos) = 1; Ítem 7 (Distinguir calidad médica) = 1; Ítem 8 (Seguridad en el uso de datos de internet) = 2. Mostraba alta familiaridad técnica con internet, pero nula competencia para discriminar rigor científico de foros alarmistas desregulados (fenómeno de **cibercondria**).

Intervención Clínica: Se descartó patología maligna mediante exploración física minuciosa; se prescribió "alfabetización digital": prescripción de fuentes acreditadas (portal de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria - semFYC) y normas de higiene digital frente a motores de búsqueda con sesgo de gravedad.

Reevaluación a los 3 meses: eHEALS ascendió a **32 / 40**, con cese de las búsquedas compulsivas nocturnas de síntomas y normalización de la ansiedad médica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos de la Red:

- **Automedicación y Terapias Peligrosas:** Pacientes que compran fármacos no regulados o suspenden quimioterapia atraídos por bulos virales en internet.
- **Cibercondria Severa:** Ansiedad patológica desencadenada por la búsqueda reiterada de síntomas médicos en la web.

Diagnóstico Diferencial:

- **Destreza Tecnológica vs. eHealth Literacy:** Manejar ágilmente teléfonos inteligentes no equivale a tener juicio crítico biomédico sobre la información leída.
- **Trastorno de Ansiedad por Enfermedad:** La conducta de chequeo en internet actúa como compulsión que alimenta el círculo de pánico.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006). eHEALS: The eHealth Literacy Scale. *Journal of Medical Internet Research*, 8(4), e27. <https://doi.org/10.2196/jmir.8.4.e27>
- Paramio Pérez, G., Almagro, B. J., Hernando Gómez, Á., & Aguaded, J. I. (2015). Validación de la escala eHealth Literacy (eHEALS) en población universitaria española. *Revista Española de Salud Pública*, 89(3), 329-338. <https://doi.org/10.4321/S1135-57272015000300010>
- Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006). eHealth literacy: essential skills for consumer health in a networked world. *Journal of Medical Internet Research*, 8(2), e9. <https://doi.org/10.2196/jmir.8.2.e9>
- van der Vaart, R., van Deursen, A. J., Drossaert, C. H., Taal, E., van Dijk, J. A., & van de Laar, M. A. (2011). Does the eHealth Literacy Scale (eHEALS) measure what it intends to measure? Validation study among patients with rheumatic diseases. *Journal of Medical Internet Research*, 13(4), e126.